Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5020853-21.2021.8.21.0010/RS

AUTOR: VALENTINA COLLA (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC))

RÉU: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

VALENTINA COLLA ajuizou *ação ordinária com antecipação de tutela*, em face de **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MÉDICOS LTDA**, devidamente qualificada aos autos.

Relatou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela Unimed Nordeste -RS, possuindo carteira de identificação nº 0 041 000100100985 8. Referiu ser portadora de doença neurogenética denominada Neurofibromatose tipo 1, que em razão do avanço da doença e refratariedade do tratamento anterior, fora solicitado pelo médico oncologista o tratamento com medicamento Koselugo (Selumetinibe) 25mg/m2, para uso oral duas vezes a dia. Disse que o medicamento é necessário para o tratamento, e que possui o devido registro na ANVISA. Ocorre que entrou em contato com a ré para fornecer o medicamento, a qual negou o pedido alegando a ausência de previsão no rol da ANS. Aduziu que somente o médico habilitado poderá dizer qual o melhor tratamento indicado para o tratamento, não significando estar adstrito apenas às recomendações da ANS. Discorreu sobre os riscos inerentes a não realização do tratamento exigido. Invocou a incidência do CDC. Pugnou pela antecipação de tutela, para, no prazo de 24 horas, determinar que a ré proceda com o custeio do medicamento Koselugo (Selumetinibe) 25mg/m2, duas vezes ao dia, nos termos traçados na receita médica, por prazo indeterminado, sob pena de multa diária de R$15.000,00. Postulou a concessão da AJG. Pediu a total procedência da ação, para reconhecer a responsabilidade da ré quanto ao custeio integral de todas as despesas relacionadas ao tratamento com tratamento Koselugo (Selumetinibe) 25mg/m2. Atribuiu à ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Deu a causa o valor de R$30.000,00. Juntou documentos (evento 1).

Deferido a antecipação de tutela pretendida. Ainda, restou deferido a concessão da AJG e a inversão do ônus da prova (evento 4).

A parte ré apresentou embargos de declaração (evento 10). Inicialmente, defendeu a necessidade de efeito suspensivo. Impugnou a concessão da antecipação de tutela a parte autora, visto que sequer houve negativa por parte da embargante, bem como qualquer solicitação administrativa do medicamento. Referiu que o referido medicamento postulado não possui bula que diga acerca das indicações do fármaco, bem como dos efeitos, riscos e contraindicações. Aduziu a inexistência de urgência. Requereu o acolhimento dos embargos, de modo que determine a imediata revogação da liminar deferida. Juntou documentos.

O Ministério Público opinou pela majoração da multa diária deferida (evento 17).

Citada, a ré apresentou contestação (evento 20). Inicialmente, discorreu sobre a inexistência de pedido administrativo, sem qualquer comprovação da suposta negativa de cobertura quanto ao fármaco postulado. Teceu comentários sobre a modalidade de plano de saúde contratada pela parte autora, na qual é submetido às disposições e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Discorreu sobre o caráter experimental da indicação da referida medicação, posto que não é possível avaliar a eficácia e a segurança da medicação. Afastou a ocorrência de abusividade, em face da ausência de previsão no Rol da ANS. Rechaçou a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a total improcedência do feito, condenando a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência. Juntou documentos.

Os embargos de declaração apresentados pela ré foram desacolhidos. Determinada a intimação da demandada, para comprovar o fornecimento da mediação postulada (evento 22).

A Unimed comprovou o cumprimento da antecipação de tutela - Evento 26.

Houve réplica (evento 29).

Intimada as partes acerca da produção de outras provas, bem como da realização de audiência de conciliação (evento 35); a autora manifestou interesse na realização de audiência de conciliação (evento 39); e a ré postulou a realização de prova pericial (evento 41).

Ambas as partes apresentaram seus quesitos periciais (eventos 47 e 48).

Foi deferida a perícia médica (evento 43).

Realizada perícia médica, sobreveio laudo pericial (evento 83).

Com vista, as partes se manifestaram (eventos 90 e 91).

O Ministério Público se manifestou opinando pela procedência do feito, diante da eficácia do medicamento (evento 94).

Encerrada a instrução (eventos 96), as partes apresentaram seus memoriais finais (eventos 100 e 101).

Intimada, a autora se manifestou dos documentos juntados com os memoriais da ré (evento 109).

É o relatório. Decido.

A pretensão da parte autora é de que a ré seja obrigada a fornecer o medicamento Koselugo (Selumetinibe) 25mg/m2, para uso oral, duas vezes ao dia, por ser portadora de doença neurogenética denominada Neurofibromatose tipo 1, conforme indicado pelo médico assistente - Evento 1, RECEIT7.

A demandada, por sua vez, referiu que não houve negativa do fornecimento do medicamento, uma vez que sequer houve pedido administrativo. Disse que o plano de saúde da autora exclui expressamente da relação negocial e da cobertura securitária o custeio de tratamentos off-label.

Gize-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificando tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art.51, IV, §1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Considera-se também exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

De acordo com o laudo médico, Dra. Viviane Sonaglio (Evento 1, RECEIT7), a autora é portadora do CID Q85, doença neurogenética denominada Neurofibromatose tipo 1. Alegou a necessidade do uso sulemetinibe na dose de 25mg/m², por via oral, duas vezes ao dia, referindo que em estudos clínicos o tratamento promoveu uma taxa de resposta confirmada de 70%, com duração do benefício por ao menos 12 meses em 80% dos respondedores

Sra. Valentina Colla **Dt. Nasc.:** 30/01/2012

Receita Comum

Paciente valentina Colla , 9 anos, portadora doença neurogenética denominada Neurofibromatose tipo 1, apresenta como critérios diagnósticos : múltiplas manchas cafe com leite , neurofibroma plexiforme com comprovação anatomo-patológica em hemiface direita envolvendo nervo trigemeo , regiao parasselar . A lesão envolve a carotida e se insinua pelo cavum de Meckel e pelo forame oval . em direção ao espaço parotideo . Alem disso estende-se ao espaço imfratemporal e segue atraves do forame infraorbitario ate as partes moles pre - maxilaes , . Lesão invade cavidade orbitaria , envolve nervo optico e determina efeito compressivo . Paciente apresenta dor de dificil controle o que prejudica qualidade de vida de maneira significativa; , . Sabe-se que trata-se de uma doença genética, com espectros clinicos diversos . A presença de neurofibromas plexiformes contribui com a morbi-mortalidade da doença de maneira significativa . A presença de tais lesoes com comprometimento de estruturas nobres como vias aereas e coluna , com compressão medular , são apresentações da doença com grande comprometimento na qualidade de vida e com prejuizo significativo e ate risco de morte. Outro risco significativo dessas lesoes é a transformação maligna desses tumores, com prognóstico extremamente reservado.

Recentemente , em literatura médica , temos relatos de respostas significativas com o uso de inibidores de MEK , em especial SELUMETINIBE para pacientes com neurofibromas plexiformes extensos . Medicação apresenta beneficio clínico em paciente pediátricos que fizeram uso e toxicidade aceitavel . A medicação foi aprovada pelo FDA e pela ANVISA e segue em analise final para comercialização em nosso país.

A aprovação é baseada nos resultados do estudo clínico de fase II**SPRINT (N Engl J Med 2020 Apr 9;382(15):1430-1442)** o qual avaliou o uso de **selumetinibe** na dose de 25 mg/m2, por via oral, duas vezes ao dia . O tratamento promoveu uma taxa de resposta confirmada de 70%, com duração do benefício por ao menos 12 meses em 80% dos respondedores.

Solicito avaliação do quadro da paciente em questão para uso da medicação cuja indicação torna-se indiscutivel . Pelo comprometimento da qualidade de vida da paciente (dor de dificil controle em uso de altas doses de medicação com comprometimento da vida diária) solicito urgencia na liberação da medicação em questão .

De acordo com o documento do Evento 20, PARECER3, a ré negou a cobertura dos medicamento, sob os seguintes argumentos:

CONSIDERANDO O CASO EM TELA DESCARACTERIZANDO URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA

Conforme laudo do medico solicitante da medicação, Dra. Viviane Sonaglio de 14 de julho de 2021, beneficiaria não está internada ou com risco de morte. Foi caracterizada urgência pela medica pois paciente apresenta comprometimento da qualidade de vida (dor de difícil controle em uso de altas doses de medicação com comprometimento da vida diária). Pelo descrito no laudo, beneficiaria não tem comprometimento agudo ou rapidamente progressivo dessa doença. A neurofibromatose do tipo I é uma doença genética que aparece já ao nascimento. Portanto, o seu tratamento não é considerado urgência ou emergência pela literatura médica.

Existem outras alternativas de tratamento disponíveis como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, acompanhamento multidisciplinar que nem ao menos foram aventadas ou solicitadas para a operadora. Não há relato no laudo médico de que alternativas de tratamento tenham sido tentadas e que não tiveram sucesso. Não foi dada alternativa para a operadora oferecer outras alternativas de tratamento. O caso poderia ter sido avaliado por cirurgião especializado para avaliar se é ressecável ou não, poderia ser oferecido pelo plano alternativa para controle adequado da dor e outros sintomas. Avaliação de outros médicos especialistas para verificar se a paciente teria outras alternativas de tratamento.

CONCLUSÃO

Considerando que **não há dados em literatura científica atual que considere a droga imprescindível para o caso em questão**, podemos inferir que se constitui em mais uma opção de tratamento com necessidade de dados mais robustos que comprovem sua eficácia.

Produto selumetinibe é de alto custo, sem previsão de cobertura pelos Planos de Saúde conforme DUT 64 da RN 465 por ser de uso via oral continuo domiciliar. Não considerado urgência ou emergência e não há dados se outros tratamentos tenham sido esgotados antes de utilizar esta medicação.

O medicamento indicado pela médica assistente possuiu registro na ANVISA nº 1161802850018 - Evento 1, ANEXO8.

A autora é beneficiária do plano "UNIPART NACIONAL32" - Evento 20, CONTR2, o qual prevê a exclusão de cobertura dos procedimentos não constantes expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Evento 17, CONTR2.

Realizada a perícia médica, respondeu o Expert - Evento 83, LAUDO1:

Quesitos da autora.

4- A medicação prescrita à periciada, Selumetinibe (Koselugo), possui aprovação da ANVISA, para tratamento de patologia(s) e/ou caso(s) análogo(s) ao(s) da periciada? Explique expressando, ou não concordância, em termos dos benefícios ao paciente neuroncológico, sob uso da referida droga.

Sim.

5- Informe se o Selumetinibe (Koselugo) é uma medicação também devidamente aprovada pela comunidade acadêmica científica internacional (FDA-Estados Unidos da América e/ou outras), para tratamento de patologia(s) e/ou caso(s) análogo(s) ao(s) da periciada?

Sim.

7- Informe se existe medicamento com efeitos, eficácia similar, índices de redução tumoral e melhora sintomatológica e da dor superiores ao Selumetinibe (Koselugo) que esteja disponível na rede pública (SUS), para o tratamento da periciada. Explique.

Não há.

8- Seria correto afirmar que a medicação Selumetinibe (Koselugo) estaria bem indicada, trazendo para o tratamento, benefícios à periciada em relação ao aumento da sobrevida/ qualidade de vida? Explique.

Sim.

10- Seria correto afirmar que sem a medicação prescrita à periciada poderia se implicar em aumento do seu risco de morte, diminuição da sua sobrevida/ expectativa/ qualidade de vida (perda de chance), com redução das perspectivas de resposta ao tratamento, caracterizando ainda a eventual interrupção do tratamento já instituído em uma iatrogenia? Explique

Sim. Pois há risco de evolução da mesma.

Quesitos da ré:

8. Qual é o tratamento recomendado para a doença que acomete a Beneficiária?

O que está prescrito, objeto deste processo

9. Há recomendação na literatura médica para o uso de Selumetinibe (Koselugo), no tratamento neurofibromatose tipo 1?

Sim.

11. O tratamento com Selumetinibe (Koselugo) enquadra-se no conceito de tratamento experimental?

Sim.

12. O presente caso enquadra-se no conceito de urgência ou emergência?

Não.

13. Os medicamentos solicitados pela autora são considerados seguros para o quadro clínico apresentado?

Sim.

15. O medicamento solicitado faz parte do protocolo usualmente recomendado para tratamento da patologia da autora? \

Não.

16. O tratamento proposto é considerado off-label?

Sim.

17. Existem outros tratamentos que poderiam ser realizados no estágio de doença da demandante e que poderiam oferecer bons resultados com mais segurança?

Não.

Ao final, concluiu o Perito:

9 - CONCLUSÃO: Recentemente, em literatura médica, temos relatos de respostas significativas com o uso de inibidores de MEK, em especial SELUMETINIBE para pacientes com neurofibromas plexiformes extensos. Medicação apresenta beneficio clínico em paciente pediátricos que fizeram uso e toxicidade aceitável. A medicação foi aprovada pelo FDA e pela ANVISA e segue em análise final para comercialização em nosso país. A aprovação é baseada nos resultados do estudo clínico de fase II SPRINT (N Engl J Med 2020 Apr 9;382(15):1430- 1442) o qual avaliou o uso de selumetinibe na dose de 25 mg/m2, por via oral, duas vezes ao dia. O tratamento promoveu uma taxa de resposta confirmada de 70%, corn duração do benefício por ao menos 12 meses em 80% dos respondedores. No caso em tela, devido a impossibilidade de ressecção cirurgica sua lesão, comprometimento do sistema nervoso central e resposta ao tratamento obtida, o uso da medicação em tela encontra-se de acordo com o quadro clinico e a escassa literatura médica.

Consoante a Lei n. 14.454, que alterou a lei 9.656/1998, editada em 21-9-2022, indica que o rol da ANS constitui referência básica no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, ou seja, é meramente exemplificativo.

"[...]
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Oportuno esclarecer que a limitação do critério médico na escolha de procedimento para o tratamento da doença é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica, *in verbis:*

"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente".

Dessa forma, cabe ao médico assistente, o qual é conhecedor do quadro clínico, determinar qual o tipo de tratamento mais adequado ao caso, prescrever os métodos e os procedimentos mais indicados para o paciente, bem como os materiais e medicamentos que deverão ser utilizados.

Ou seja, é vedado ao plano de saúde insurgir-se contra as determinações do médico quanto aos medicamentos e materiais utilizados no procedimento e que objetivam reduzir os riscos do paciente e, em consequência, os custos do plano de saúde, desde que comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou, ainda, que haja recomendação pela Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Possuindo o contrato firmado pelas partes cobertura de tratamento para a moléstia apresentada pela parte autora, como no caso da presente demanda, não pode o plano, agora, negar-se a arcar com as despesas do medicamento indicado pelo médico do paciente, alegando a exclusão da cobertura de tratamentos *off label*, uma vez que preenchidos todos os outros requisitos, quais sejam: cobertura para moléstia apresentada; comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

Assim, havendo cobertura contratual para a moléstia apresentada pela parte autora e estando o medicamento indicado pela médica assistente registrado na ANVISA, com a confirmação da eficácia a partir do laudo pericial, incumbe ao plano de saúde demandado fornecer o medicamento prescrito, restando superada a questão da taxatividade do rol da ANS, nos termos da Lei n. 14.454/2022.

Nesse sentido, é o posicionamento do TJ/RS:

> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. *PLANO* DE *SAÚDE*. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. **APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O FATO DE A MEDICAÇÃO SER "*OFF LABEL*", OU SEJA, EMPREGADA PARA USO CUJA INDICAÇÃO NÃO ESTÁ NA BULA, NÃO CONSTITUI ÓBICE AO SEU FORNECIMENTO PELA OPERADORA DO *PLANO* DE *SAÚDE*. É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DE *PLANO* DE *SAÚDE* QUANDO A DOENÇA DO PACIENTE NÃO CONSTAR NA BULA DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE MINISTRA O *TRATAMENTO* (USO "*OFF-LABEL*")** (AGINT NO ARESP 1.713.784/SP, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 15/3/2021, DJE 7/4/2021). APELO NÃO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50043178420208210004, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-10-2022). [Grifei].

Logo, tenho por evidenciada a responsabilidade do plano de saúde demandado pela cobertura do tratamento prescrito pela médica assistente à autora, devendo arcar com os valores do medicamento Koselugo (Selumetinibe) 25mg/m2, para uso oral, duas vezes ao dia.

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação proposta por **VALENTINA COLLA** contra **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA**, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para tornar definitiva a tutela antecipada, condenando a ré à cobertura integral do tratamento indicado à autora - Koselugo (Selumetinibe) 25mg/m2, para uso oral, duas vezes a dia, com custeio das despesas pelo respectivo plano de saúde.

Pelo princípio da sucumbência, imponho à demandada o pagamento das despesas processuais, mais honorários ao procurador da parte autora, que fixo em R$3.000,00, a ser corrigido pelo IPCA a contar desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, observado o singelo desenrolar da causa e demais critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Intimem-se. Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO BERNSTEIN, Juiz de Direito**, em 16/12/2022, às 17:5:0, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10030419127v24** e o código CRC **a5e88c30**.